



2026

居家健康管理平台 解决方案

- 突破时空，健康不再遥远

INTERNATIONAL MEDICAL SUMMIT FORUM

01

目录

<https://www.ypppt.com/>



政策背景



居家健康管理方案



物联网设备



平台的定义及医院
健康管理现状



医院落地方式及应
用科室



案例分享

01

O N E

项目背景



国家政策-互联网+医疗健康，推进居家医疗康复服务

国卫老龄发〔2024〕40号

《国家卫生健康委 民政部 国家医保局
国家中医药局、国家疾控局关于促进医
养结合服务高质量发展的指导意见》

国办发〔2018〕26号

国务院办公厅印发《关于促进“互联
网+医疗健康”发展的意见》

健康中国2030规划纲要

中共中央、国务院印发《“健康中2030
规划纲要”》

1、推动健康老龄化，增强老年人健康养老获得感，五部门提出：要加强质量管理，医养结合机构强化责任，卫生部门开展质量控制评价并规范机构管理；提升服务质效，组建专业团队、完善协作机制、加大医保支持、发展居家社区服务、推进“互联网+医养结合”，发挥中医药优势，全方位促进医养结合服务高质量发展。

1、鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。

2、支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。

3、鼓励利用可穿戴设备获取生命体征数据，为孕产妇提供健康监测与管理。

1、鼓励创新医疗卫生服务供给模式，完善服务体系。

2、大力发展互联网的健康服务模式，高效配置优质医疗资源，从医院、社区到家庭下沉医疗服务，充分合理利用创新平台提升医疗服务水平。

需求群体

- 1、时间、交通不便的周期性康复患者
- 2、术后身体不便的患者
- 3、老龄化康复需求
- 4、年幼需要陪同就诊的患儿群体
- 5、活动受限的康复需求的患者
- 6、健康管理需求人群

01

O N E

平台的定义



搭建医院治疗到居家康复管理的桥梁

打造疾病康复管理新方式

圆爱康智慧家康——拥有一套创新医疗健康管理、运营服务的综合性体系，

院内专科运营管理系统

院内外协同治疗服务系统

居家康复客户服务支持平台

快捷融合物联网设备搭载系统

四位一体，完成了从医院到家庭健康管理的SAAS化建设，完善互联网+医疗健康快速落地的流程化建设，助力国家医疗健康服务模式改革，是医疗新质生产力的践行者。



创新居家健康管理服务项目



我们愿与更多的合作伙伴共同开发新的健康管理服务和产品



居家医疗综合运营服务—应用科室及项目

服务科室	服务项目
妇科	盆底康复/人流康/内膜养护
消化内科	食道癌筛查/便秘治疗
生殖中心	内膜养护/子宫壁增厚治疗/卵巢储备功能下降
产科	42天内全产康服务/乳腺疏通
神经内科	吞咽困难治疗/缺血性预适应训练
泌尿科	直肠康复/尿失禁/尿潴留/前列腺疼痛
肛肠科	排便功能障碍
康复科	吞咽困难治疗/肌肉萎缩治疗/中医康复
儿科	儿童心理康复/吞咽困难治疗



02

T W O

居家健康管理方案



打造医院治疗与居家健康管理一体化

院内整体评估 治疗



创新“六师共管”服务体系



监测病程及时调整健康管理治疗方案



医护管理端

遵医嘱居家治疗



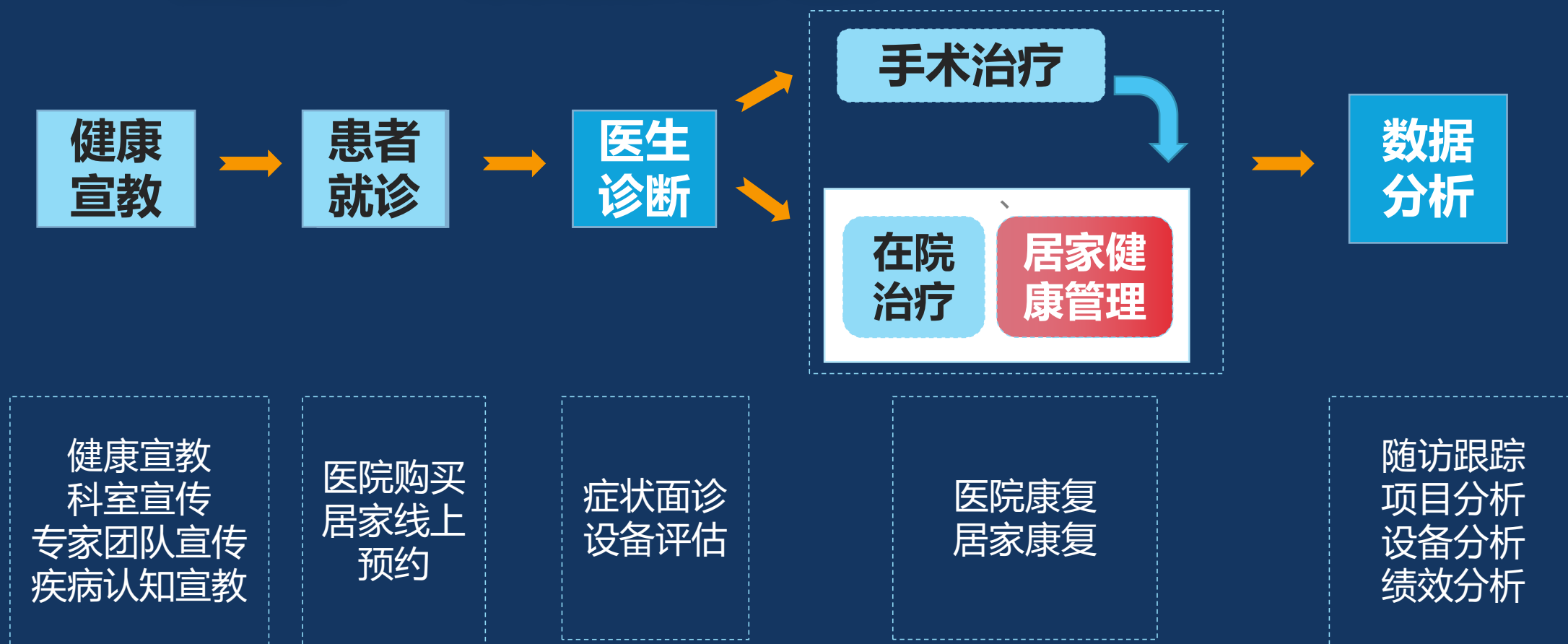
生物反馈电刺激治疗仪



患者端小程序



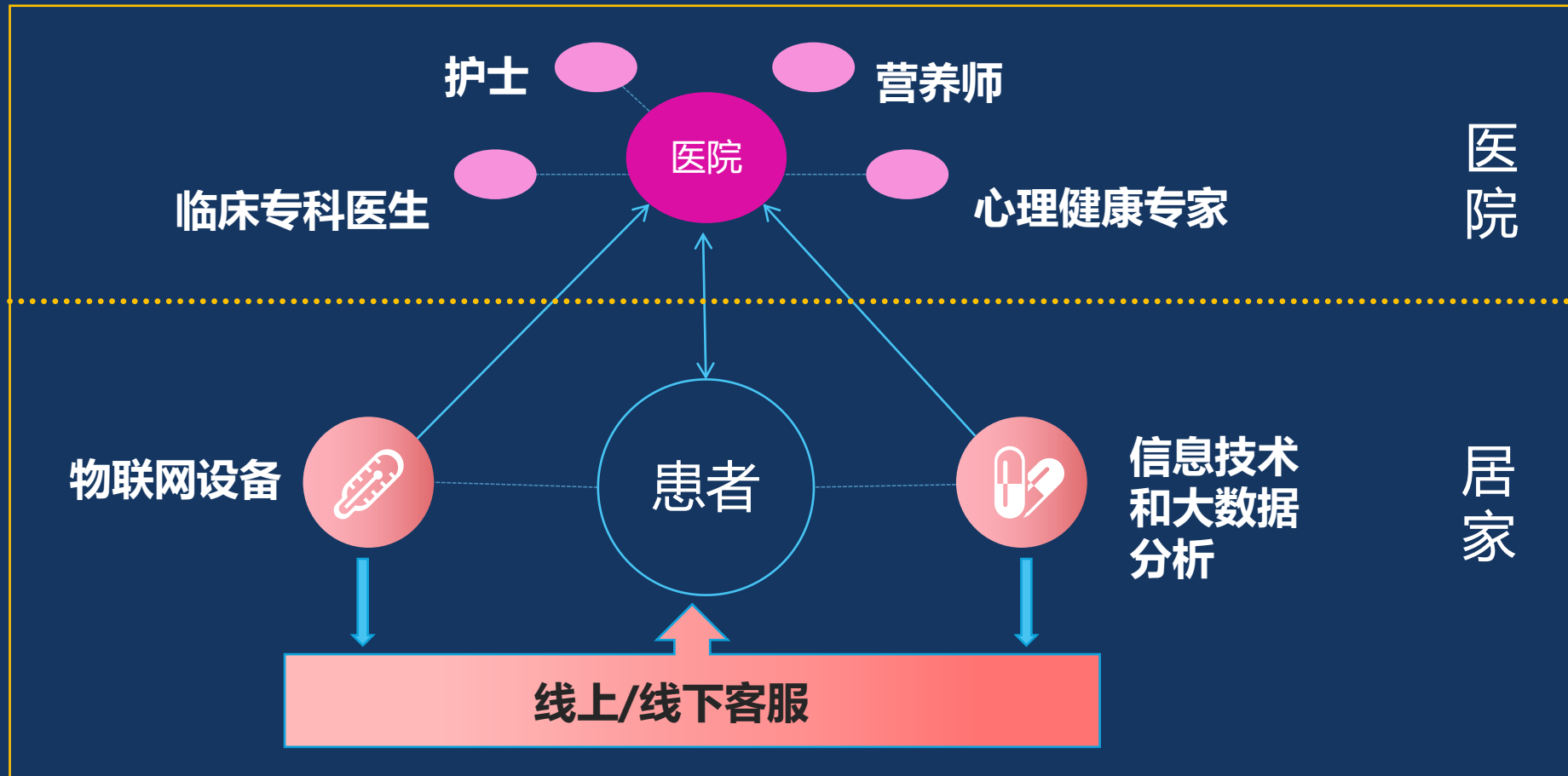
在医院——为患者提供更多选择



院内整体评估，医护远程指导，个性化居家康复

智慧家康——居家健康管理闭环

预防和早期干预



目标：改善患者的整体健康状况，预防疾病的发生和进展，提高生活质量，并降低医疗费用和资源的浪费。



两大核心能力：打造居家管理闭环



支持多项目物联网设备, 统一支撑医生与患者的互联互通

搭建可穿戴设备及系统管理体系



- 客服团队、健康管理团队、医疗团队跨团队合作，利用互联网工具，联接线上和线下诊疗服务，让健康和疾病人群获得全程化的健康照护和完整的健康档案。

03

T H R E E

医院项目落地模式及案例分享

居家健康管理服务—医疗机构落地方式



圆爱康智慧家康——“客服”落地服务 + “六师共管”落地执行

- 医生在线进行方案的制定，评估报告的解读
- 患者居家通过APP连接设备进行康复治疗
- “六师共管”患者管理服务体系，服务患者居家康复全流程

圆爱康智慧家康——项目服务支撑

- 1、免费提供治疗用物联网设备
- 2、物联网设备回收、清洗、消毒及物流
- 3、为项目提供医院到居家的技术和服务支撑
- 4、为项目搭建“六师共管”客服支持体系
- 5、提供用户端小程序，医生管理小程序、PC管理平台、以及AI数据分析、活动运营及引流技术支持
- 6、引进和对接新项目入院服务



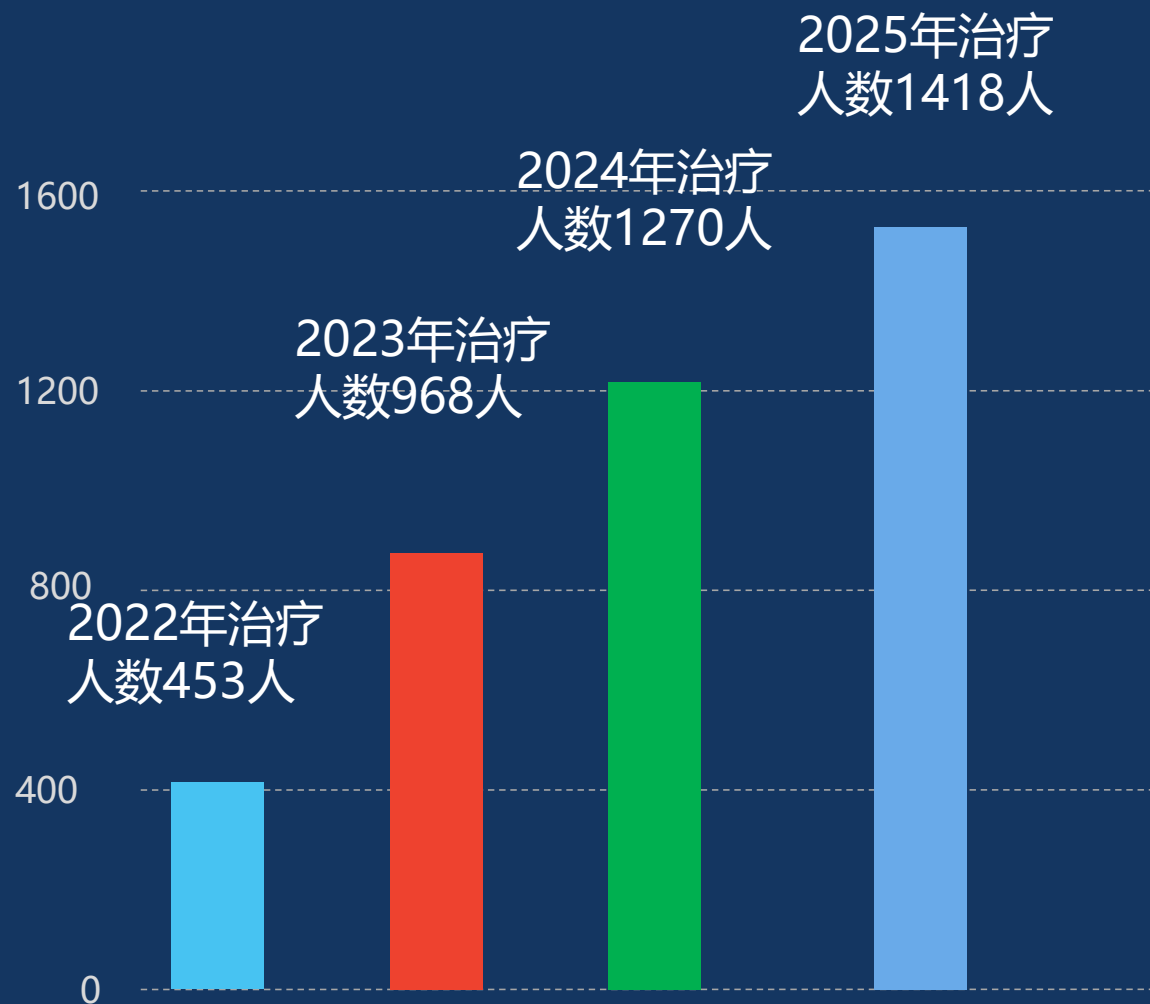
05

O N E

案例分享



案例介绍 - 患者就诊人数增长



××人民医院

开展居家康复项目后,
盆底患者整体 增量**180.3%**
科室 收入提高 **194万**



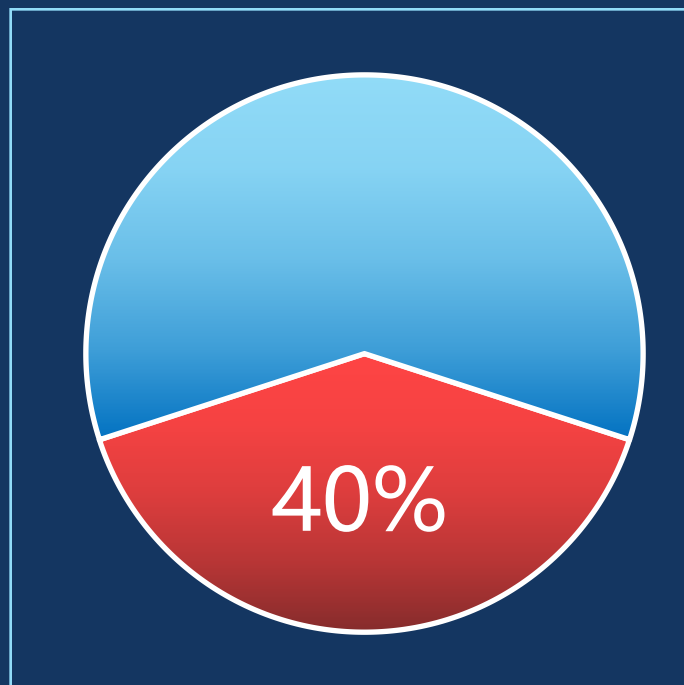
开通盆底居家治疗服务之前



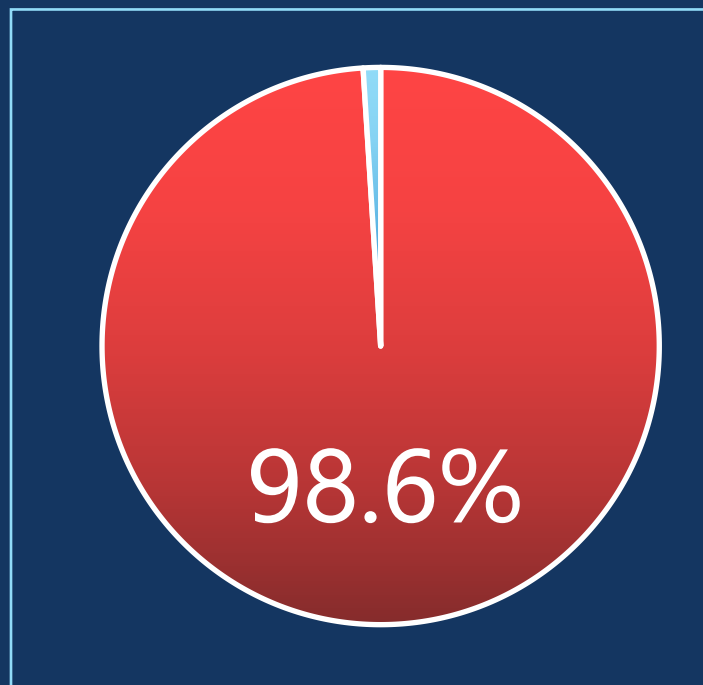
开通盆底居家治疗服务之后



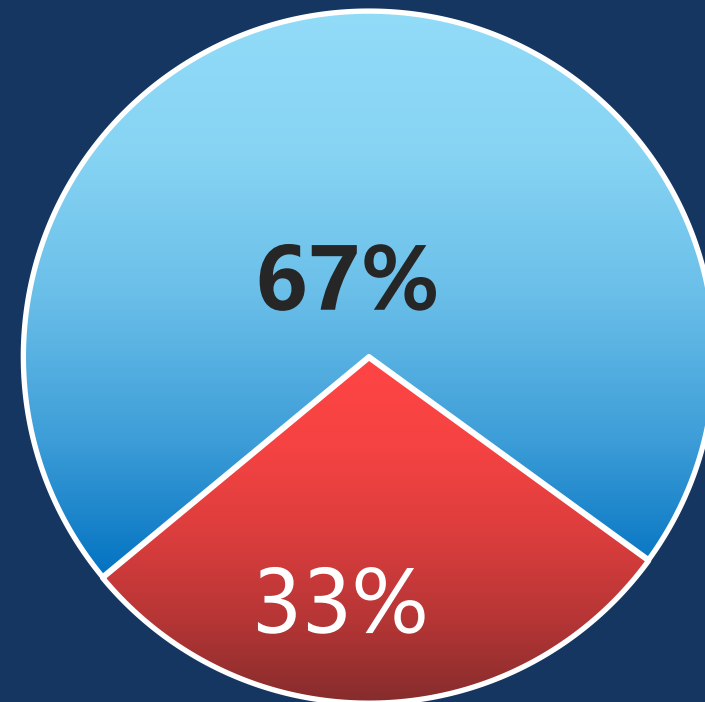
案例介绍 - 患者治疗完成率、复购率提升



医院治疗



居家治疗



复购率增加

院内

居家

居家

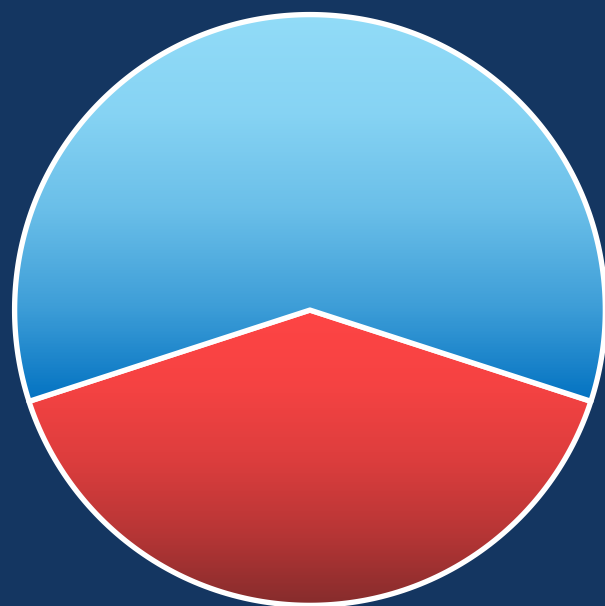
院内



医从性和完成率统计口径：按照2-3次1周的频率进行治疗，完整的治疗完一个疗程



产品效果 - 居家治疗效果显著



2025居家康复治疗收入：194万

医院治疗收入：106万

居家

院内

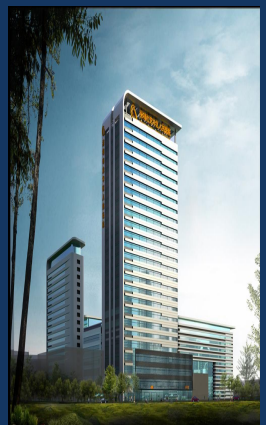
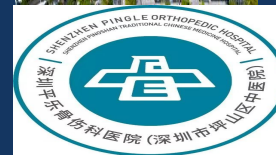
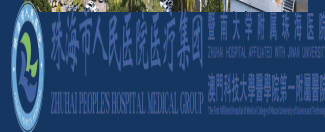
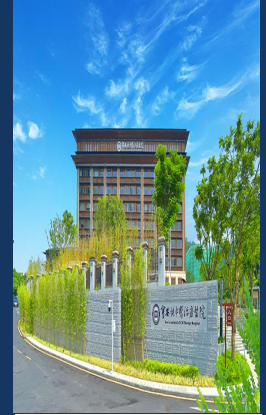
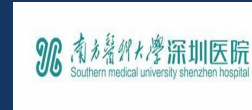
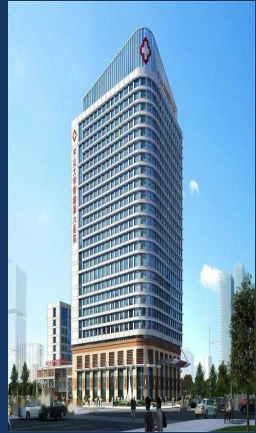
05

F O U R

科室明星项目



部分用户



06

物联网设备

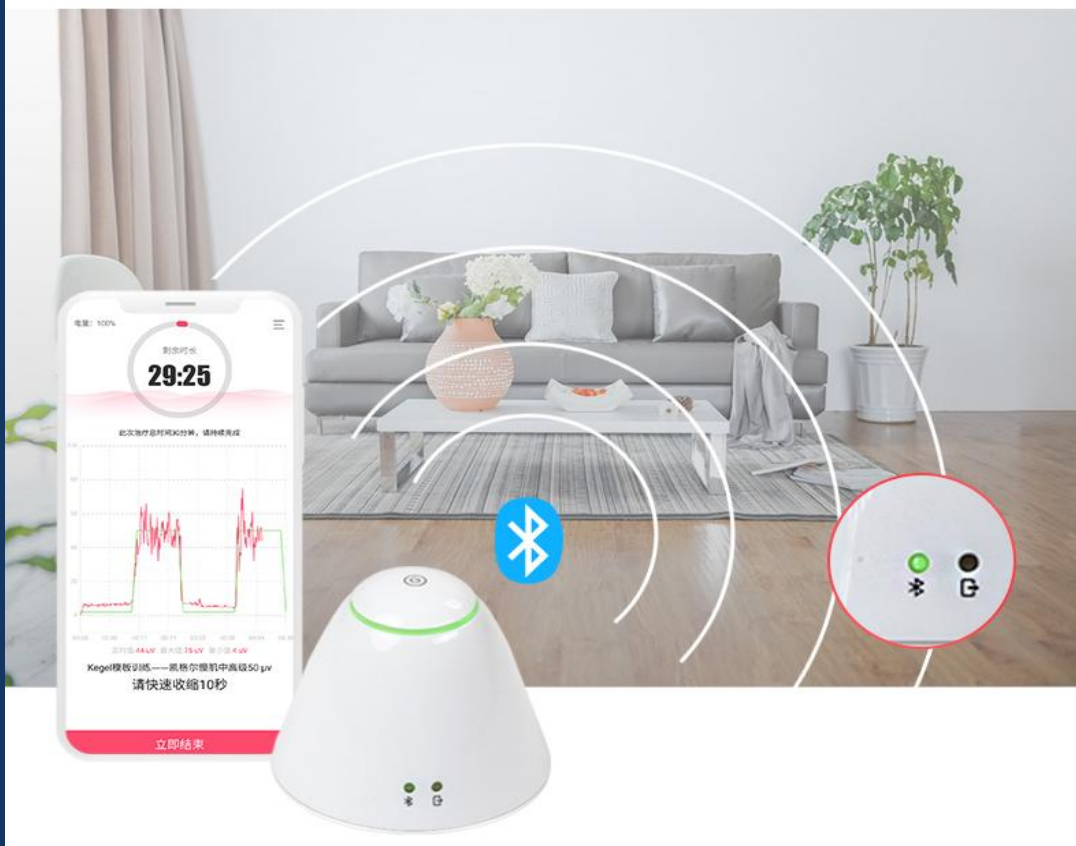
- 1) 生物反馈电刺激治疗仪
- 2) 可穿戴关节活动测量仪
- 3) 食道癌筛查
- 4) 缺血预适应训练仪
- 5) 智能营养管理餐盘



一、物联网设备 - 生物反馈电刺激治疗仪

蓝牙传输 简单快捷

传输更稳定、连接更简便、轻松做盆底肌训练



与院内设备相同疗效、相同技术原理

生物反馈电刺激治疗仪 - 评估

使用效果一目了然



国际标准的表面肌电评估

- 采用国际标准的表面肌电评估方法
- 评估盆底肌肉功能状态
- 有正常人对照值,
- 采集精准1 μ v

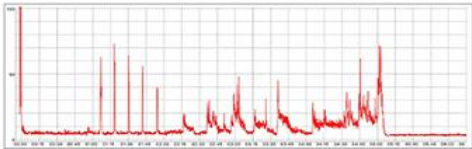
用户使用报告

使用前

盆底肌肉功能评估报告

姓名:	性别:	年龄:	身高:	体重:	检查号:	1
测试日期:	2019-01-16	分娩类型:	(n/a)	分娩日期:	(n/a)	
阶段	指标	测试值	参考值			
前静息阶段	平均值	5.29	2-4 μ V			
	变异性	0.71	<0.2			
快肌 (I 类肌) 测试阶段	快速收缩时间	0.20	<0.5s			
	最大值	59.20	35-45 μ V			
	快速放松时间	0.20	<0.5s			
慢肌 (II 类肌) 测试阶段	平均值	13.64	30-40 μ V			
	变异性	0.37	<0.2			
	平均值	17.15	25-35 μ V			
耐力测试	变异性	0.55	<0.2			
	后 10 秒/前 10 秒比值	3.12	0.8-1.0			
	平均值	3.43	2-4 μ V			
后静息阶段	变异性	0.24	<0.2			

盆底肌肉表面肌电图



报告解读说明:

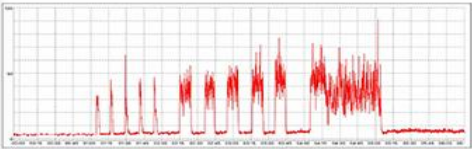
1. 前静息阶段: 测试肌肉放松能力。平均值大于4 μ v, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿频、膀胱痛、外阴痛、便秘等症。
2. 快肌 (I 类肌) 测试阶段: 测试快肌肌力和反应速度。肌力不足可引起压力性尿失禁、性高潮障碍、阴道干涩等症。
3. 慢肌 (II 类肌) 测试阶段: 测试慢肌肌力和收缩稳定性。肌力不足以及稳定性差可引起器官脱出或脱垂、阴道松弛、性冷淡、反复泌尿生殖道感染等。
4. 耐力测试阶段: 测试慢肌的耐力。均值和后10秒/前10秒比值的降低, 反映慢肌的耐力较差, 易疲劳, 可引起盆腔疼痛、阴道松弛等症。
5. 后静息阶段: 测试肌肉收缩后放松能力。平均值大于4 μ v, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿频、膀胱痛、外阴痛、便秘等症。

使用后

盆底肌肉功能评估报告

姓名:	性别:	交	年龄:	18	检查号:	1
测试日期:	2019-01-26	分娩类型:	(null)	分娩日期:	(null)	
阶段	指标	测试值	参考值			
前静息阶段	平均值	3.02	2-4 μ V			
	变异性	0.11	<0.2			
	快速收缩时间	0.21	<0.5s			
快肌 (I 类肌) 测试阶段	最大值	47.00	35-45 μ V			
	快速放松时间	0.20	<0.5s			
	平均值	37.36	30-40 μ V			
慢肌 (II 类肌) 测试阶段	变异性	0.33	<0.2			
	平均值	37.52	25-35 μ V			
	变异性	0.30	<0.2			
耐力测试	后 10 秒/前 10 秒比值	1.59	0.8-1.0			
	平均值	5.71	2-4 μ V			
	变异性	0.16	<0.2			
后静息阶段	平均值					
	变异性					

盆底肌肉表面肌电图



报告解读说明:

1. 前静息阶段: 测试肌肉放松能力。平均值大于4 μ v, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿频、膀胱痛、外阴痛、便秘等症。
2. 快肌 (I 类肌) 测试阶段: 测试快肌肌力和反应速度。肌力不足可引起压力性尿失禁、性高潮障碍、阴道干涩等症。
3. 慢肌 (II 类肌) 测试阶段: 测试慢肌肌力和收缩稳定性。肌力不足以及稳定性差可引起器官脱出或脱垂、阴道松弛、性冷淡、反复泌尿生殖道感染等。
4. 耐力测试阶段: 测试慢肌的耐力。均值和后10秒/前10秒比值的降低, 反映慢肌的耐力较差, 易疲劳, 可引起盆腔疼痛、阴道松弛等症。
5. 后静息阶段: 测试肌肉收缩后放松能力。平均值大于4 μ v, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿频、膀胱痛、外阴痛、便秘等症。

与院内设备相同疗效、相同技术原理

生物反馈电刺激治疗仪 - 治疗模式

01

神经肌肉电刺激

被动训练

通过脉冲电流刺激特定肌肉群，以达到“功能”修复的目的。

神经肌肉电刺激可用于治疗多种疾病，包括神经损伤、肌肉疾患、关节炎和疼痛等。

主被动训练

在患者完成动作的过程中，达到事先设定的阈值，设备给予电刺激辅助患者完成动作，让不断重复的运动模式信息，传入中枢神经系统，逐渐恢复原有的功能。

肌电触发电刺激

02

03

Kegel模板训练

主动模版训练

根据设备给予的模版，在语音提示下通过自主的、反复的盆底肌肉群收缩和舒张，增强盆底肌张力、恢复松弛的盆底肌。

通过采集到的盆底肌表面肌电信号为动作，进行多媒体游戏。

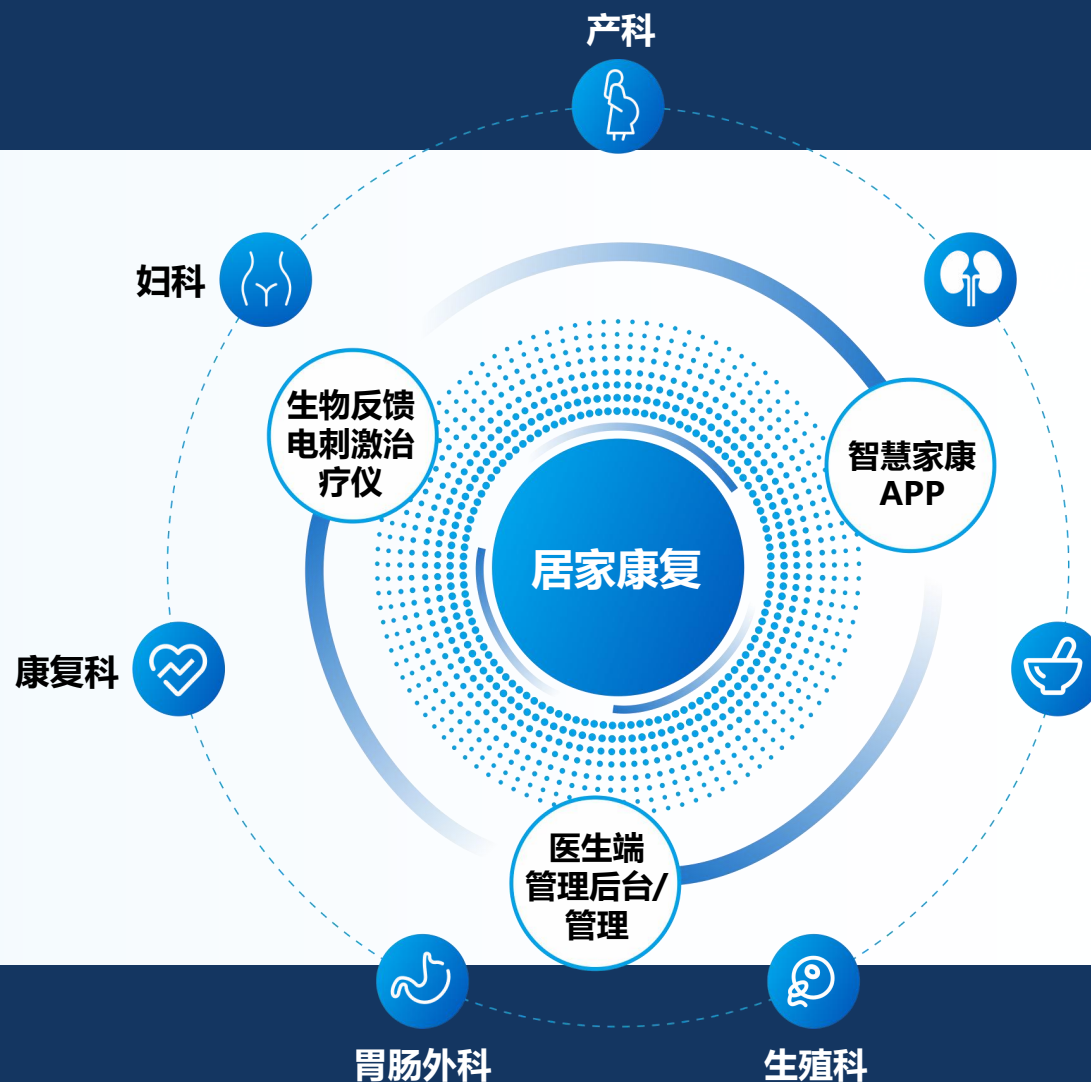
多媒体生物反馈训练

04

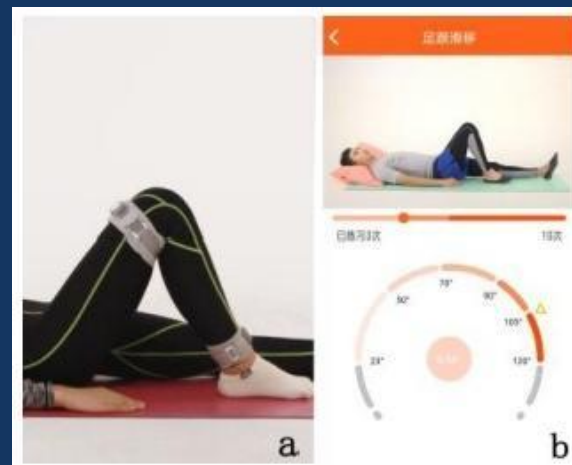


生物反馈电刺激治疗仪 – 应用

产品可覆盖**妇科、产科、泌尿外科、胃肠外科、生殖科、中医科和康复科**的患者，实现对盆底肌、腹直肌、脊骨、骨盆、全身整体的康复治疗。同时，智慧家康积极跟医院深度合作，布局线下实体医疗场景，“三位一体”为患者提供盆底康复治疗方案。



二、物联网设备——可穿戴关节活动度测量仪



智慧医疗项目一可穿戴关节活动度测量仪

- 国内首款骨科术后远程康复监测系统；跟踪关节活动监测训练情况；量化功能数据，智能风险预警；及时反馈医生，助力患者管理；提升康复效果，降低医疗成本。
- 适用范围：本品适用于患者术后四肢关节的活动度测量、系统化管理及康复训练

国外研究数据

CoPYRIGHT 02015 BY THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY, INCORPORATED

A commentary by Mark J. Spangehl, MD,

eC FRCS(C) is linked to the online version of this article at jbjs.org.

In-Home Telerehabilitation Compared with Face-to-Face Rehabilitation After Total Knee Arthroplasty

A Noninferiority Randomized Controlled Trial

家庭远程康复与全膝关节置换术后面对面康复相比-非劣效性随机对照试验

The comparison of telerehabilitation and face-to-face rehabilitation after total knee arthroplasty: A systematic review and meta-analysis

examg, xomneal, koncu

全膝关节置换术后远程康复与面对面康复的比较：系统评价和荟萃分析。

BMJ Open Clinician perceptions of a prototype wearable exercise biofeedback system for orthopaedic rehabilitation: a qualitative exploration

Rob Argent,^{1,2,3} Patrick Slevin,^{2,3} Antonio Bevilacqua,² Maurice Neligan,¹ Ailish Daly,¹ Brian Caulfield^{2,3}

临床医师对原型可穿戴式运动生物反馈系统对骨科康复的认识：定性探索

0926

BMJ Musculoskeletal Disorders

The effectiveness of inpatient rehabilitation after uncomplicated total hip arthroplasty: a propensity score matched cohort

Justine M Naylor^{1,2,3} Andrew Hatl,⁴ Mital,⁵ Ian A Harris^{1,2,3} and Wei Xuan^{1,3}

住院康复不值一简单的全髋关节置换术后住院康复的有效性：倾向评分与队列相匹配

没有显著差异！

国内专家共识

编者按：国家卫生和计划生育委员会(以下简称“国家卫生计生委”)公益性行业科研专项《关节置换术安全性与效果评价》项目组(以下简称“项目组”)建立了涵盖26家项目组医院和50家推广医院数据库。根据要求,该项目完成后需建立一套相关的专家共识。为此,项目组和《中华骨与关节外科杂志》联合中华医学会骨科学分会关节外科学组、中国医疗保健国际交流促进会骨科分会关节外科委员会,组织国内相关专家对数据资料进行整理、分析与挖掘,并召开了多次多学科专家讨论会,同时结合国内外相关文献,遵循循证医学原则,起草并完成了《中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期管理策略专家共识》,本共识涉及总体策略、贫血诊治、疼痛与睡眠管理、血栓管理、血液管理等内容,具体细化为已发表的《中国髋、膝关节置换术围术期抗纤溶药物贯抗凝血药应用方案的专家共识》、本刊同期发表的《中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期贫血诊治专家共识》,以及将陆续发表的《中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期疼痛与睡眠管理专家共识》、《中国髋、膝关节置换术加速康复——心血管病患者围术期血栓管理专家共识》等系列共识。

中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期管理策略专家共识

国家卫生计生委公益性行业科研专项《关节置换术安全性与效果评价》项目组
中华医学会骨科学分会关节外科学组
中国医疗保健国际交流促进会骨科分会关节外科委员会

周宗科¹ 翁习生² 4曲铁兵 张先龙⁴ 严世贵⁵ 曹力 “朱振安⁷ 廖威明* 钱齐荣 杨柳⁰ 朱庆生△ 吴海山史占军黄伟⁴ 赵建宁¹⁰ 钱文伟 廖刃¹⁵ △刘斌¹ 5孙学礼^{1°} 王坤正^{17°} 邱贵兴” 裴福兴

(1. 四川大学华西医院骨科, 成都610041; 2. 中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院骨科, 北京100730; 3. 北京朝阳医院骨科, 北京100020; 4. 上海市第六人民医院骨科; 上海200233; 5. 浙江大学第二附属医院骨科, 杭州310009; 6. 新疆医科大学第一附属医院骨科, 乌鲁木齐830054; 7. 上海交通大学医学院附属第九人民医院骨科, 上海200011; 8. 中山大学附属第一医院骨科, 广州510080; 9. 上海长征医院骨科, 上海200003; 10. 第三军医大学西南医院骨科, 重庆400038; 11. 第四军医大学西京医院骨科, 西安710032; 12. 南方医科大学南方医院骨科, 广州510515; 13. 重庆医科大学第一附属医院母乱 雨中A0016. 1A 南吉军区总医院县到南言210000. 16四川士学化西医院度醉到成都610041.

可穿戴设备的应用将成为未来的发展趋势！

1.5 功能锻炼

术前积极功能锻炼可以增加肌肉力量,减轻术后疼痛,缩短术后恢复时间,减少住院时间及费用。积极功能锻炼有利于关节功能的早期恢复,减少相关并发症(。良好的疼痛控制有利于早期功能锻炼,增强肌肉力量和增加关节活动度。

推荐: ①患者教育与功能锻炼,增加肌肉力量; ②手术当天即可床上及下床功能锻炼; ③良好的疼痛控制措施下,进行积极主动功能康复,尽早达到术前制定目标。

1.6 出院后管理

THA 和 TKA 患者出院后继续进行有效的镇痛、VTE 预防、功能锻炼可促进加速康复四。THA 和 TKA患者术后可以选择到康复医院、社区医院或回家进行康复锻炼。研究表明,THA 和TKA患者术后回家进行康复锻炼对关节功能的恢复尤为重要,且减少医疗费用四。出院后的DVT 发生率与住院期间相当,出院后继续应用抗凝血药对预防出院后DVT 尤为重要四。

推荐: 根据患者情况选择到康复医院、社区医院或回家进行功能康复。①出院后继续应用抗凝血药预防VTE;②出院后有疼痛者应继续口服镇痛药,睡眠障碍者服用镇静催眠药; ③继续功能锻炼。

1.7 随访管理

术后定期随访便于评价患者功能恢复程度,督促患者积极进行功能康复,及时发现并处理并发症0。

推荐: ①术后2~3周随访: 检查切口,拆线,评价关节功能状况,治疗疼痛、睡眠障碍及预防VTE 等。②定期随访、指导康复,进行效果评价。

核心技术



蓝牙4.0 BLE技术



姿态传感器



人体姿态算法



聚合物锂电池



专家制定方案



软件实时指导



日常监测跟踪



数据云端同步

- 蓝牙运动传感器：准确监测患者的运动范围弯曲和伸展以及顺应性
- 无线患者连接：患者可以随身携带PT：他们不受束缚系统的限制
- 简单的患者仪表板：提供者可以快速了解患者的治疗进展情况
- 游戏化体验：动机体验鼓励患者实现目标
- 移动患者监控：提供者可以通过智能手机方便地访问每位患者的结果
- 安全的应用内消息：患者和提供者可以发送短信，视频或照片；请求提供者的电话和/或预约；并进行视频通话
- 自定义协议：为每个患者提供标准化康复方案，并根据需要灵活进行修改
- 交互式患者应用程序：通过治疗指导患者，并提供虚拟治疗师来反映他们的动作

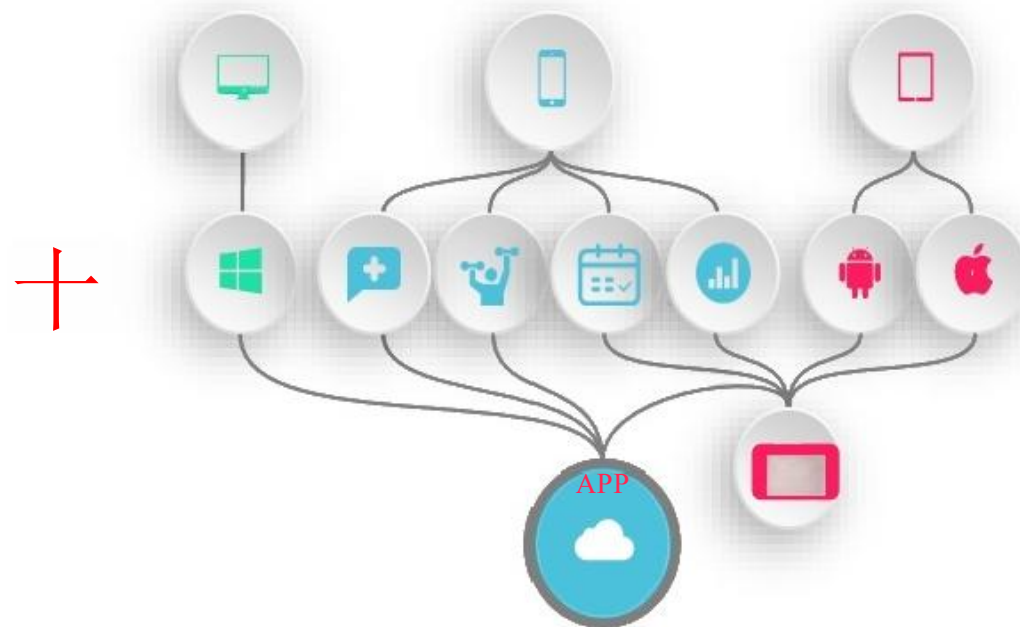
远程康复监测系统

促进和改善患者在骨科术后的家庭康复

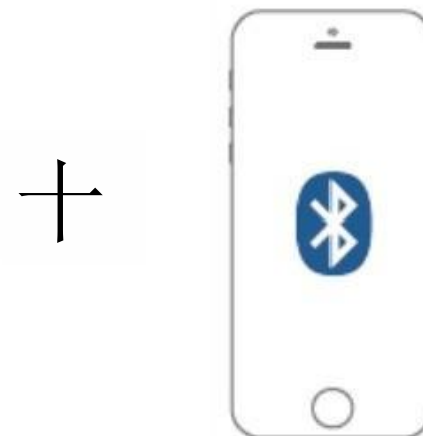
1、智能可穿戴硬件



2、软件系统



3、智能手机



软件系统操作：医生端+患者端

在线康复视频库，指导患者自行锻炼



上肢康复动作指导视频：

主要覆盖肩袖损伤、上肢骨折康复动作



髋部康复动作指导视频截图：

主要覆盖髋关节置换患者、下肢骨折(髋部)康复动作

膝部康复动作指导视频：



主要覆盖膝关节置换患者、膝关节韧带损伤患者、骨性关节炎未置

换患者、下肢骨折(膝关节周围)康复动作



踝部康复动作视频：

主要覆盖踝部慢性损伤患者、踝部骨折术后患者康复动作。

其他辅助训练动作视频：



此类动作主要用于锻炼肌肉力量、平衡能力和核心肌力或指导康复过程中需要特殊注意的动作要领。这些动作可间接促进肢体和关节功能恢复，是康复中不可获取的补充训练，主要典型动作包括：



手机APP可在线观看康复指导视频和关键点

三、物联网设备 - 食道癌筛查

国内首创、填补空白 食康1号

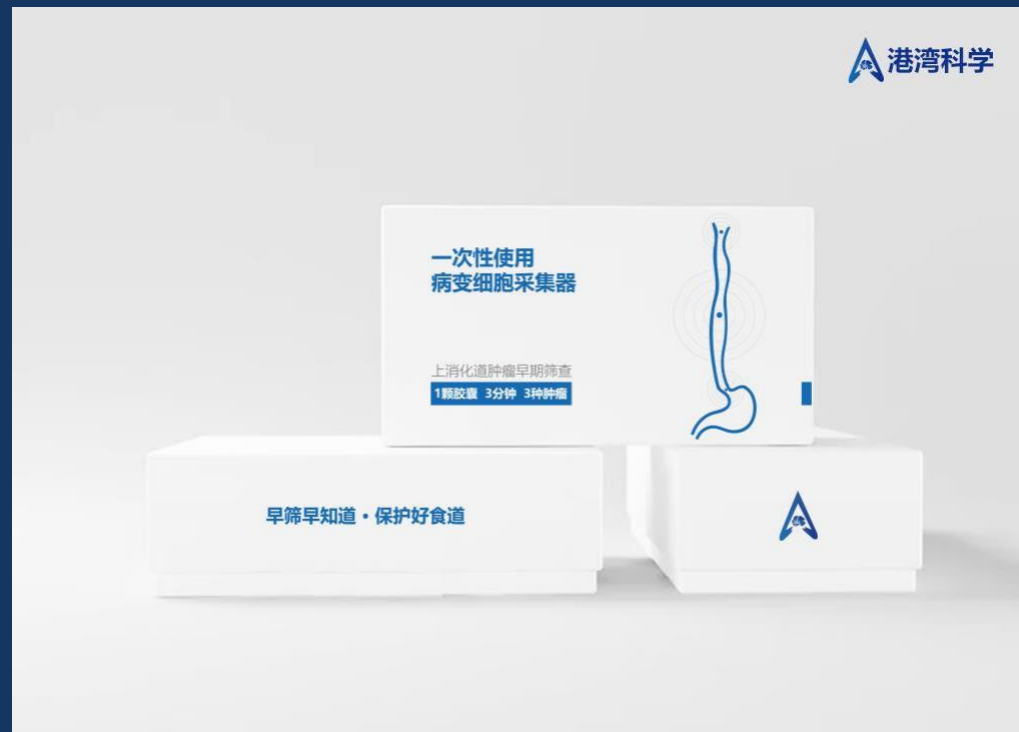
国家消化系统疾病临床医学研究中心
李兆申院士、王洛伟教授团队领衔研发

创新性 唯一性

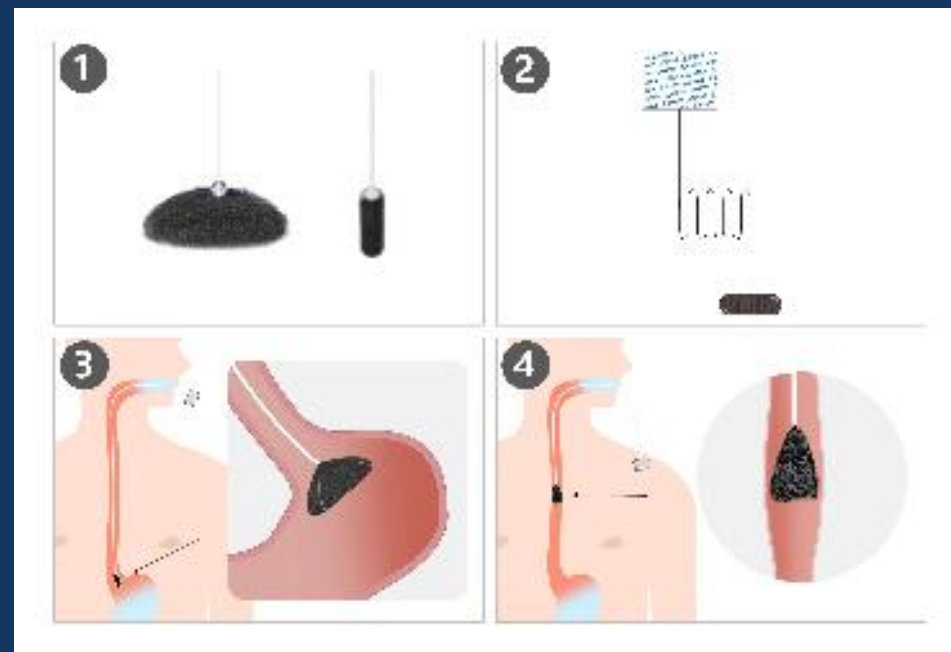
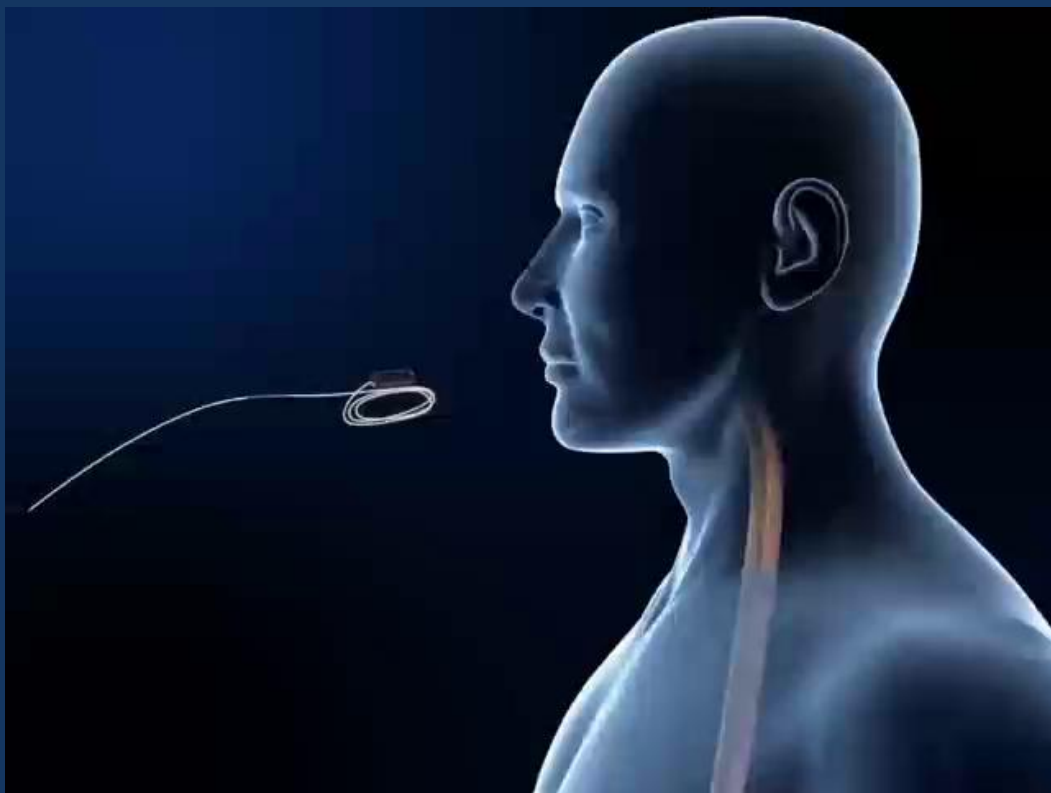
敏感性94.5%，特异性91.9%

安全、高效、无创、便捷

食管、贲门、口咽镜前早筛



物联网设备——食道癌筛查



适用范围



规模人群普筛



高危人群筛查



常规健康体检

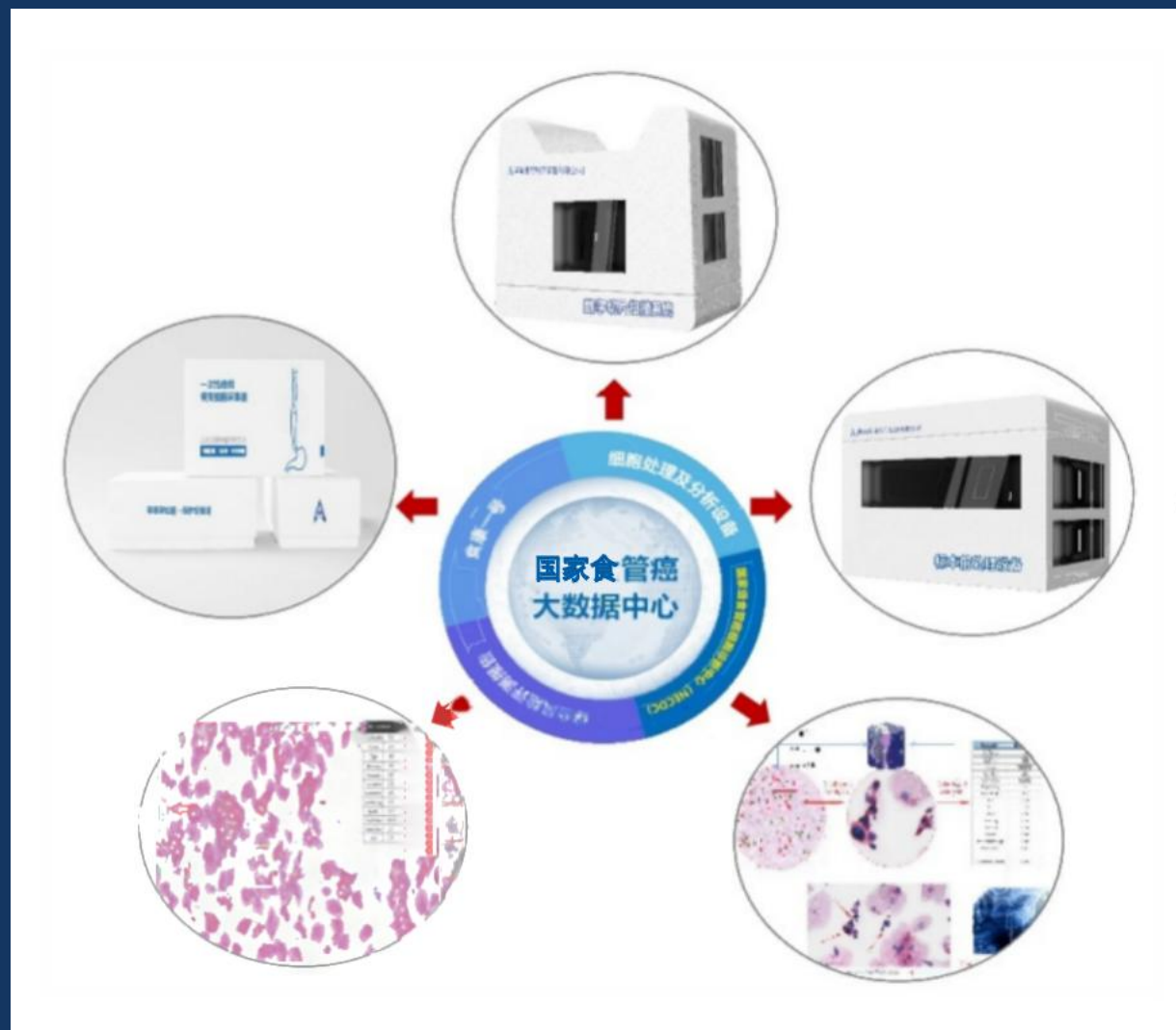


术后随访复查



技术组成

- 新型细胞收集器 (食康1号)
- 标准化细胞前处理设备、智能分析系统
- 食管癌大数据中心
- 食管癌细胞诊断中心 (NECDC)
- 多维度综合风险评测报告系统



行业标准——《中国食管癌筛查与早诊早治指南》



中华人民共和国国家卫生健康委员会
National Health Commission of the People's Republic of China

目前唯一高效安全、镜前筛查食管鳞癌方法

中国食管癌筛查 与早诊早治指南 (2022, 北京)

旧导：
aor 士位 4x2: 221
引症：
MF 节 A07, Ww5 市

- (A) **不推荐**使用传统球囊拉网细胞学检查进行食管癌早期筛查(弱推荐, 证据分级: 中)
- (B) 推荐使用食管新型细胞收集器(食康1号)进行Barrett食管筛查(弱推荐, 证据分级: 中)
- (C) 推荐使用食管新型细胞收集器(**食康1号**)进行内镜前食管癌初筛
(**强推荐**, 证据分级: **中**)

比较, 患有食管鳞状上皮轻度异型增生($IR=4.5$, 致更高的成本。因此, 本指南推荐5岁或预期寿命< 中国食管癌筛查与早诊早治指南(2022, 北京)

95%CI:2.82-7.34)、中度异型增生($IR=15.18$, 5年者终止筛查。

95%CI:8.98~25.66)、重度异型增生($HR=55.78$, 95%CI:29.78~104.49)的个体具有更高的食管癌发病风险。这两项研究都在中国食管癌高发地区开展, 研究人群为长期居住于食管癌高发区的人群, 因此在这两项研究中, 当地一般人群的食管癌发病率也高于全国平均发病水平(19.28/10万)。

(五) 筛查和早期诊断办法

临床问题10: 食管新型细胞收集器筛查食管癌

的有效性

- (A) **不推荐**使用传统球囊拉网细胞学检查进行食管癌早期筛查(弱推荐, 证据分级: 中)
- (B) 推荐使用食管新型细胞收集器进行

Barrett食管筛查(弱推荐, 证据分级: 中)

(C) 推荐使用食管新型细胞收集器进行内镜前食管癌初筛(强推荐, 证据分级: 中)

2008年, 一项对无症状人群($n=740$) 开展筛查的前瞻性评估结果显示, 传统机械球囊细胞学检查诊断食管鳞状细胞异形增生或肿瘤的灵敏度为39%, 特异度为85%; 充气球囊拉网细胞学检查诊断食管鳞状细胞异形增生或肿瘤的灵敏度为46%, 特

◆ 证据来源基于本项目中由李兆申院士牵头的超30000例数据全国多中心临床验证与前瞻性研究

四、物联网设备 -缺血性预适应训练仪

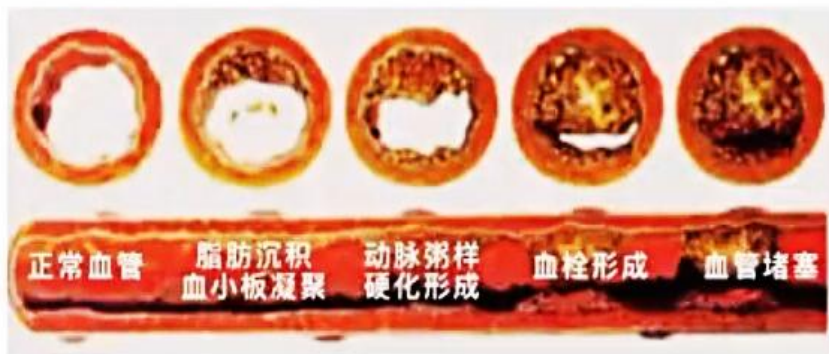


采用训练仪对双上肢进行反复多次非损伤性的短暂缺血刺激，激发人体自身抗缺血缺氧的潜能，诱导机体产生内源性保护物质如腺苷、血管生长因子等，建立侧枝循环，从而增强心脑血管等重要器官对缺血缺氧的耐受能力，减少可能发生的严重致命的缺血缺氧损害。



缺血预适应训练仪 - 作用

宣医通®缺血适应训练防止血小板聚集
减少动脉粥样硬化形成



作用一：减少斑块形成

宣医通®缺血适应训练促进血管新生
建立侧支循环

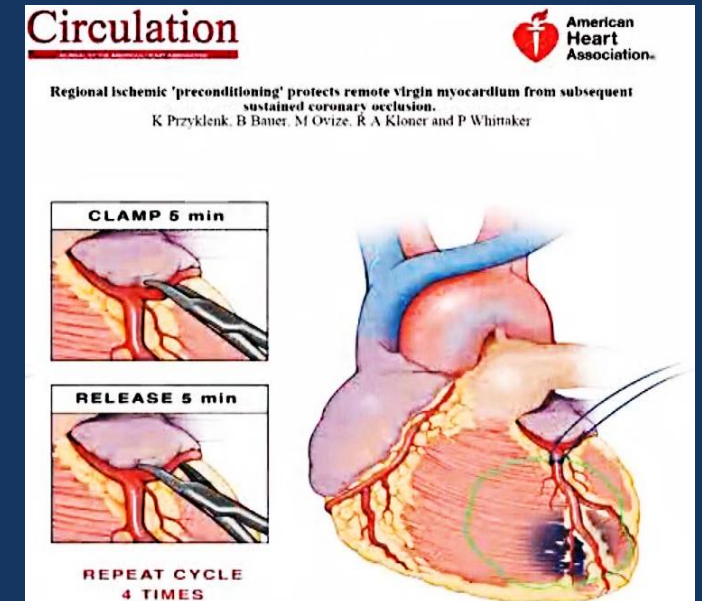
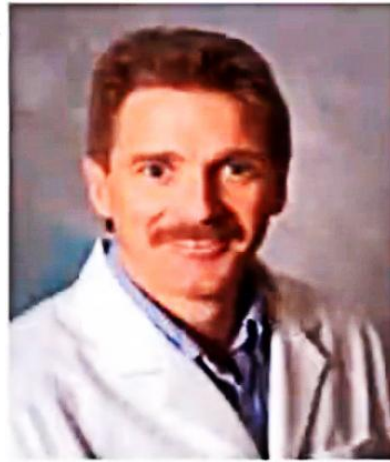
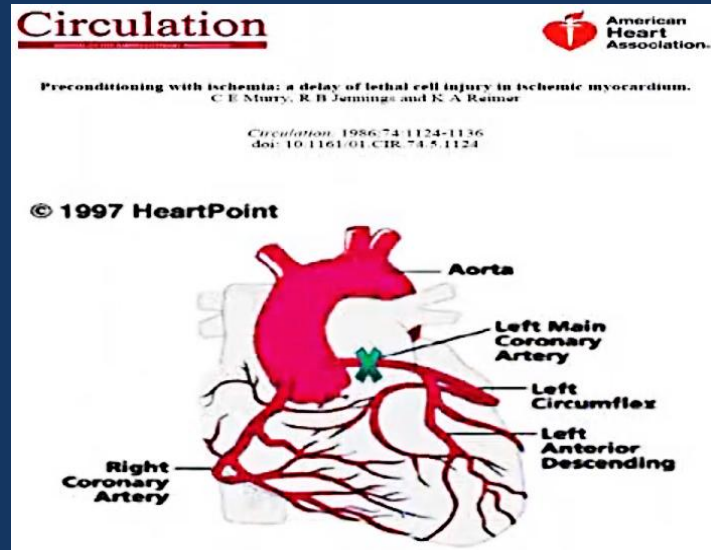


作用二：建立侧枝循环



缺血预适应训练仪 - 原位、远隔缺血训练效果

预适应训练是可以减少心梗面积，保护心肌细胞



反复、间断阻断左旋支血流（5分钟）4次，使再次阻断左旋支40分钟导致的心肌梗死范围减少75%

反复、间断阻断左旋支（5分钟）4次，使持久阻断左前降支1H的心梗范围减少70%



缺血预适应训练仪 - 双重保护时间窗

1

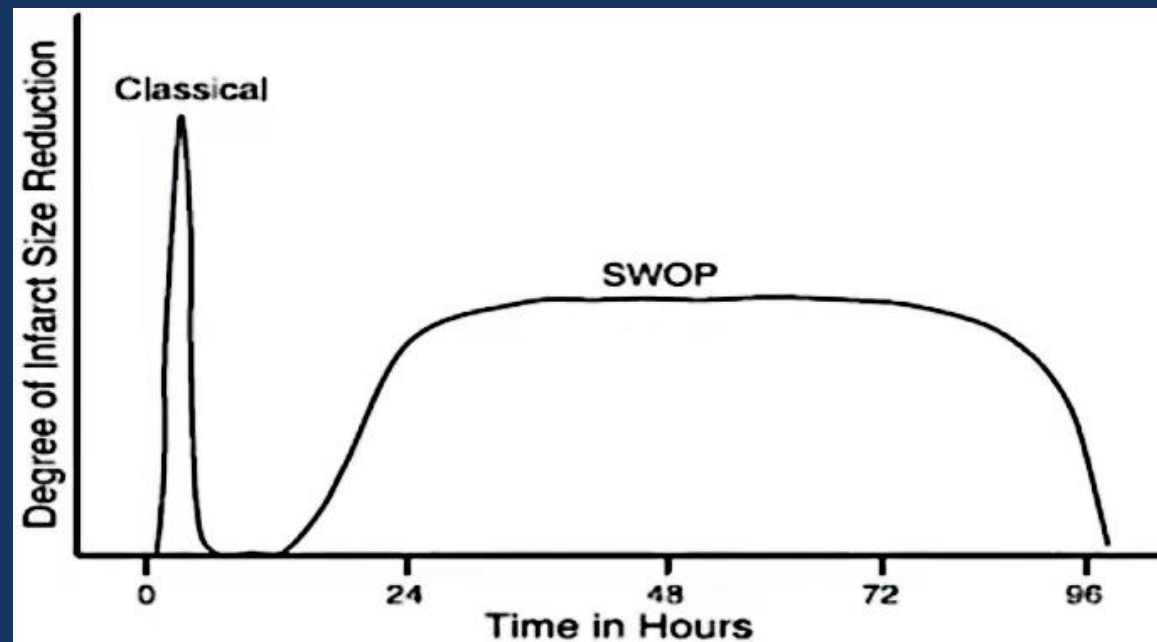
即刻作用

预处理后数分钟出现，持续2-3小时。

2

持续作用

预处理后12小时出现，持续2-3天

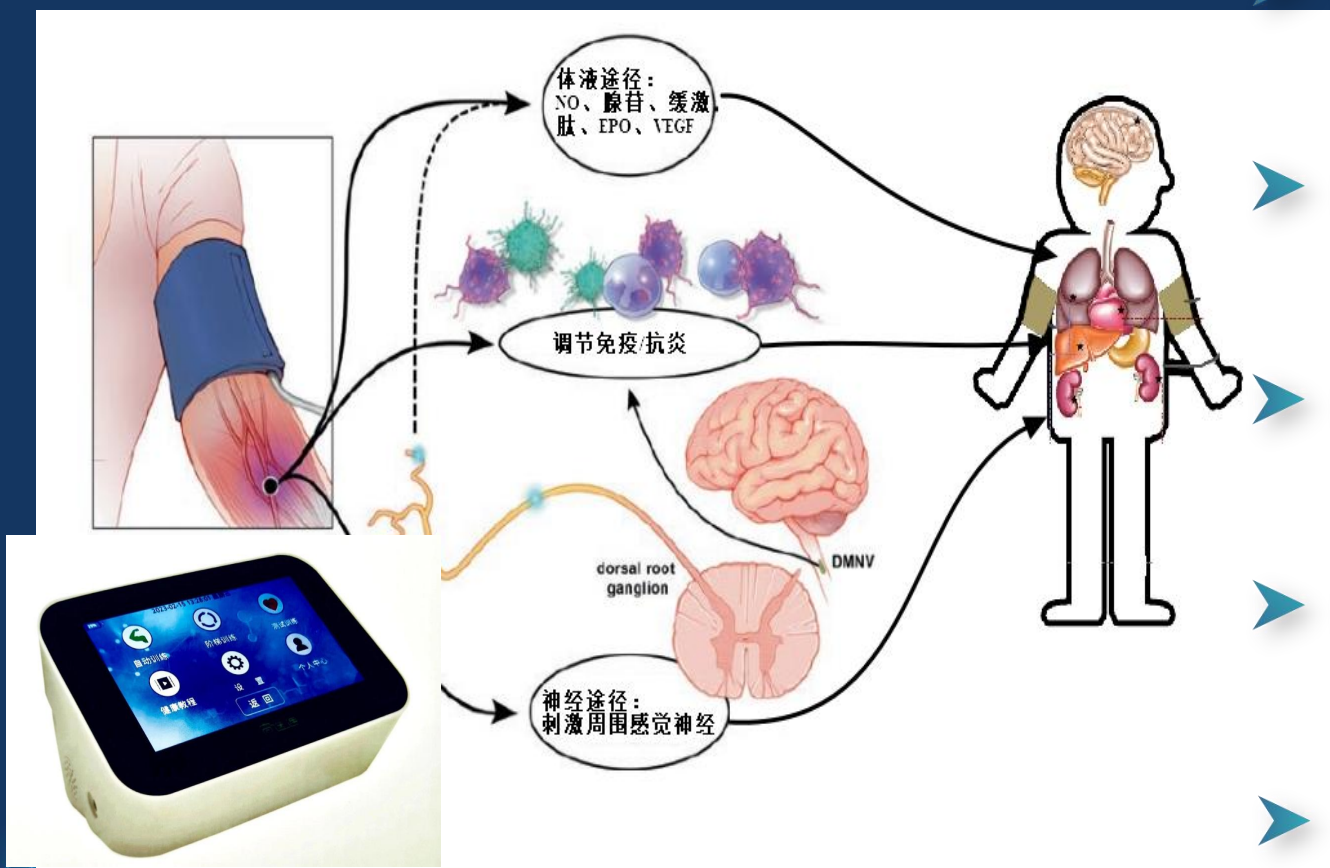


每日坚持训练



缺血预适应训练仪 - 优势

缺血预适应训练为什么可以保护大脑和心脏



缺血训练的五大优势

1

属内源性治疗，无药物副作用

2

无手术风险

3

使用安全有效

4

医院和家里都可使用，便捷

5

预防治疗都有效

五、物联网设备 - 智能营养管理餐盘



营养管理餐盘 - 界面



院外管理总结评价报告

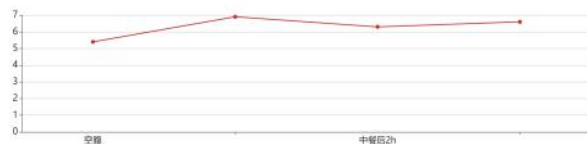
ID	██████	姓名	██████	年龄	31	身高(cm)	160
本院ID		孕前体重(kg)/孕前BMI	45/17.6(消瘦)	孕周	24 ⁺¹	胎数	单胎

1、饮食中选择的升糖指数高的食物过多，比如粥类、高糖水果、饼干；2、建议杂粮不要煮成粥，正餐吃杂粮米饭；3、建议选择低糖水果，比如苹果、柚子等，并且每日水果量在300g以内；4、建议一日蔬菜量≥500g；5、建议坚果类食物一日摄入20g以内；6、建议少吃甜食食物（腊肉）、油炸食物（油条）；7、建议饼干选择无糖低糖饼干。

2021-08-03饮食记录

✦ 信息记录及点评表（体重单位是Kg、血糖单位是Mmol/L、胰岛素单位是U国际单位）

体重和血糖及胰岛素				
空腹血糖：5.4				
早餐	食物内容及量	血糖	胰岛素注射	餐后活动
08:00	油条：50g、酸白菜(酸菜)：10g、黑米粥：200g、煮鸡蛋：50g	早餐后2h：6.9		
点评	杂粮煮成粥后，血糖生成指数会升高，影响血糖，同时孕期不建议摄入油条			
上午加餐	食物内容及量	血糖	胰岛素注射	餐后活动
10:00	哈密瓜：300g、花生(炒)：40g、牛奶：250g			
点评	坚果摄入量超标，水果一天的量是200~400g，并且建议选择低血糖生成指数的水果，比如苹果、柚子等			
午餐	食物内容及量	血糖	胰岛素注射	餐后活动
12:00	蒜蓉空心菜：100g、萝卜干炒腊肉：100g、墨鱼排骨汤：100g、米饭：150g	中餐后2h：6.3		
点评	熏制品少吃			
下午加餐	食物内容及量	血糖	胰岛素注射	餐后活动
15:00	火龙果：300g、牛奶饼干：40g			
点评				
晚餐	食物内容及量	血糖	胰岛素注射	餐后活动
18:00	荷兰豆炒虾仁：100g、爆炒肉片：50g、菠菜鸡蛋汤：150g、米饭：150g	晚餐后2h：6.6		散步30分钟
点评				
晚间加餐	食物内容及量	血糖	胰岛素注射	餐后活动
21:00	煮玉米：150g			
点评				



AI智能持续葡萄糖监测报告(AGR)

ID	██████	姓名	██████	年龄	31	身高(cm)	160
本院ID		孕前体重(kg)/孕前BMI	45/17.6(消瘦)	孕周	24 ⁺¹	胎数	单胎

总结

总体血糖平稳，主食选择还需要注意，餐后运动不能放松。

开始时间：2021-06-28 17:04:28 结束时间：2021-07-13 17:04:28 佩戴时长：360小时

葡萄糖概况

葡萄糖范围					
临床症状明显低血糖(TBR) ($<3.0\text{mmol/L}$): 0 ($<3.0\text{mmol/L}$): 0 $<1\%$	低血糖预警(TBR) ($<3.9\text{mmol/L}$): 4 ($<3.5\text{mmol/L}$): 0.2 $<4\%$	目标范围内时间(TIR) ($3.9\text{--}10\text{mmol/L}$): 95.5 ($3.5\text{--}7.8\text{mmol/L}$): 99.8 $>70\%$	高血糖预警(TAR) ($>10\text{mmol/L}$): 0 ($>7.8\text{mmol/L}$): 0 $<25\%$	临床症状明显高血糖(TAR) ($>13.9\text{mmol/L}$): 0 $<5\%$	
葡萄糖水平		血糖波动	血糖波动细节		数据充分性
平均葡萄糖(mmol/L)	eHbA1c(%)	CV(%)	SD(mmol/L)	MAGE	HBGI
4.9	4.6	10.2	0.5	0.7	0.11
4.9-6.4	$<6\%$	19-25	0.6-1.4	MODD	LBGI
				0.5	2.88
					CGM使用时间(%)
					100

单日连续图谱



院外指标及生活轨迹矩阵报告



让我们用心呵护
您的健康

